

最多见。此类药物中以非那西丁和氨基比林毒性最强,我国和许多国家早已禁止单独使用,但在复方制剂中仍然保留较低含量,若长期用也足以造成危害。

解热镇痛药致严重毒性反应多为长期使用,或短期大量使用者,因此,除个别品种用于抗风湿等慢性疾病外,一般患者应少用或不用,必要时可短期适量使用,绝对不可长期连续使用,或大量突击使用。同时要注意此类药组成的复方制剂。

3.1 骨髓毒性 安乃近、保泰松及含氨基比林的复方制剂,易发生骨髓毒性,因此,用药期间应定期检查白细胞计数,发现问题及时停药,避免不致造成严重后果。

3.2 肝、肾损害 多数解热镇痛药均可造成肝、肾损害,一般在停药后可自行恢复。但对非那西丁、氨基比林所致肾损害不可轻视,应及时处理,给予输液,并适量使用碳酸氢钠促其排泄。尽管复方制剂中含量较少,但长期使用亦有造成肾乳头坏死。对肝损害以保泰松为首。此类药物中一般认为对乙酰氨基酚比较安全,但若超量服用也会引起肝损害,每日服 6 g 可致严重肝损害,每日服 10 g 即可致死。安全品种尚且如此,其他品种更应注意,切不可随便增加药量。

3.3 胃肠道反应 阿司匹林、贝诺酯、保泰松等易引起胃肠反应,对部分病人可诱发消化性溃疡,甚至溃疡出血、穿孔。因此,为避免胃肠道反应,应注意:(1) 饭后服药;(2) 改变给药途径,如应用栓剂等;(3) 选用肠溶糖衣片;(4) 必要时可用阿司匹林的复盐注射剂。

3.4 过敏反应 一般多为轻微皮肤反应,严重者引起剥脱性皮炎、大疱性皮肤松懈症等,非常危险。因其发生快,难以预料,必须事先防范。要准确地了解病人的药物过敏史,注意到同种药物的不同制剂和不同盐类,只要有一种过敏,其他品种均不可再用。安乃近易致严重反应,若对其过敏,则含氨基比林的复方制剂也不可。若对阿司匹林类过敏,其复盐及酯类如阿司匹林

精氨酸盐、赖氨酸盐,阿司匹林钙、贝诺酯、卡巴匹林钙等均不可使用。

3.5 避免长期连续使用或大量使用 注意了解含非那西丁、氨基比林的成药,应该特别警惕不可大量服用,更不可长期服用。如氨非咖片、优散痛片、撒烈痛片、索米痛片、脑宁片、安痛定片、复方阿司匹林片等。对乙酰氨基酚在此类药中不良反应虽然较少,但其成药商品名甚多,如百服宁、泰诺止痛片、泰诺滴剂、退热净、幸福止痛素、阿莱克、速效伤风胶囊、快克胶囊、力克舒、康必得等,这些成药中有的就是乙酰氨基酚,有的是以对乙酰氨基酚为主药。应注意成药中的含药量,不可随便加服,并防止重复用药,以免发生毒副反应。尤其是某些长期的慢性疼痛患者,应防止受商品名的误导而长期服用。

4 对其他药的增毒作用

药物进入体内后以一定的比例与血浆蛋白结合,暂时失去活性,只有游离型药物才能有药理活性。但这种结合是可逆的,它可不断地与血浆蛋白解离而变成活性药物,体内游离型药物越多,作用越强,当然毒性也增强。如甲苯磺丁脲的血浆蛋白结合率为 95%,游离型仅 5%,当被解热镇痛药竞争时,使其结合率下降 5%,则等于该药的血药浓度升高 1 倍,即易引起低血糖。磺胺甲噁唑的蛋白结合率为 68%,当被竞争而下降 1/4 时,就使血药浓度上升 1/3 左右。

为避免增毒作用,阿司匹林、保泰松等一般不与以下药物合用:双香豆素、醋硝香豆素(新抗凝)、新双香豆素、华法林;甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、格列吡嗪(美吡达)、格列本脲(优降糖)、格列齐特(达美康);妥英钠、甲氨蝶呤等。如因病情确需并用时,必须减少有关药物剂量,一般减少至常用量的 1/2~1/3。

(编校:曾 星 收稿:1999-03-02)

罗红霉素、阿奇霉素与其他药物相互作用及不良反应

100039 北京 武警医学编辑部 李小萍 郭 青

大环内酯类(azalides)抗生素用于临床已有 40 多年历史。近 10 多年来,对于以红霉素(erythromycin, Em)为中心的大环内酯类药物的研究再度受到医学界的重视,其在抗生素销售排列中已位居第 3,占口服药

处方的 20%^[1]。作者就罗红霉素(roxithromycin, RXM)、阿齐霉素(azithromycin, AZM)与其他药物的相互作用及不良反应(Adverse reaction, ADR)加以综述。

1 与其他药物的相互作用

1.1 茶碱 茶碱治疗血浓度很窄,仅 20~20 mg/L。罗红霉素虽不如红霉素对其影响大,但多次给药后在正常成人中观察到茶碱清除率(CL)降低。茶碱与罗红霉素同时服用,茶碱的消除受到影响,血药浓度和药一时曲线下面积(AUC)上升,半衰期延长,说明两者合用时应对茶碱血药浓度进行监测。阿奇霉素则属另一类。口服阿奇霉素对茶碱的血药浓度、达峰值时间和药一时曲线下面积均无明显影响^[2],说明哮喘患者同时服用该药时,不需调整茶碱的剂量。但也有实验表明^[1],口服或静注后,其血脂浓度平均峰值分别为 0.21±0.08 mg/L 和 3.40±1.12 mg/L,血药浓度-时间曲线下面积的平均值分别为 1.27±0.65 mg/(L·h)和 7.14±1.34,口服阿齐霉素后其代谢产物 deselainose 增加,认为阿齐霉素吸收前的酸性降解可能影响其利用度。由此看出,阿齐霉素生物利用度低的原因与其说是由于药物的酸性降解或广泛的药过代谢作用,不如说是由于药物吸收不全所致。

1.2 环孢素 环孢素也通过细胞色素 P₄₅₀ 系统代谢,且红霉素能使其血浓度升高 3~10 倍。但心脏移植病人同时使用罗红霉素时,其环孢素血浓度却无明显升高^[2]。

1.3 卡马西平 红霉素影响卡马西平的代谢,能使口服卡马西平与罗红霉素合用者不发生相互作用。但也有文献认为卡马西平与阿齐霉素合用时,可使卡马西平清除率下降^[2,3]。

1.4 咪达唑仑 有人对 10 名健康志愿者进行双盲实验,发现罗红霉素可明显增大咪达唑仑的药一时曲线下面积、清除半衰期。阿奇霉素与第 2 氮草类药物合用未发现明显的临床相互作用^[4]。

1.5 特非那定 红霉素与特非那定联用会导致某些人心电图改变^[5]。有人发现阿齐霉素不影响特非那定药动力学,且 QT 校正间隔无明显影响。但因红霉素可直接影响心电图生理,并广泛用于幽门螺杆菌根除,故需预测严重药物相互作用,若与抗心律失常药同时应用,须进行心电图鉴别,并考虑测定血药浓度^[6]。

1.6 铝、镁制剂、H₂-受体拮抗剂 抗酸药、H₂受体拮抗药可与抗生素产生各种各样的相互作用。罗红霉素不受同时服用抗酸药的影响;雷尼替丁及抗酸药与其联用均不影响其生物利用度^[4,5]。实验证明,罗红霉素与雷尼替丁、氢氧化铝合用,对后者的吸收影响不大,且两者亦不影响罗红霉素的生物利用度。服用铝或镁等抗酸药后马上给予阿奇霉素,2 h 前给予西咪替丁,阿奇霉素的血浓度亦无变化^[2]。

1.7 奥美拉唑 据观察,奥美拉唑与罗红霉素对治疗

幽门螺杆菌的疗效,比单用奥美拉唑清除完全^[4]。

1.8 激素类避孕药 口服避孕药的健康妇女,同时给予罗红霉素,20 h 后其血清中黄体酮酯的浓度没有改变。服用阿奇霉素同时口服避孕药,未见相互作用^[2]。

2 不良反应

2.1 胃肠道反应 服用红霉素常表现为腹痛、腹胀、恶心、呕吐及腹泻等。张之荫^[2]报道下呼吸道感染 204 例,罗红霉素组有 2 例因呕吐、消化不良而中途停药。其胃肠道反应发生率为 3.1%^[3]。阿奇霉素胃肠道反应发生率为 1.3%~9.5%^[6~7]。

2.2 肝脏损害 红霉素引起肝损害是常见不良反应。据国外报道用罗红霉素引起急性肝炎 1 例;引起肝损害 157 例,其中肝酶升高 11 例,其他肝功异常 10 例,药物肝炎 20 例,胆汁郁积肝炎 8 例,黄疸 8 例。国内有人应用阿奇霉素后出现肝功异常,但停药后 4~15 d 恢复正常^[4,5],以上说明新红霉素对肝脏损害似不可忽视。

2.3 神经系统反应 应用罗红霉素可引起头痛,一般症状轻微可自行消失^[1],但也有引起严重头痛而被迫中途停药者。应用阿奇霉素有引起头痛、头晕甚至耳毒性者,严重影响正常交谈,一般停药后 2~4 周可恢复正常^[2]。

2.4 过敏反应 据梁晓丽等^[8]报道,因外耳道脓肿使用罗红霉素 2 d 后出现皮肤瘙痒的发生率为 0.2%。

2.5 其他 罗红霉素还可引起肾功能异常及血细胞、血小板的改变^[5,11]。

总之,两药分别与其他药物交互作用后阿奇霉素所受干扰较少,副作用亦较红霉素轻,但其不良反应不容忽视。因此,临床应姜素椿审核用罗红霉素或阿奇霉素时要注意询问病史,要提防过敏体质及过敏史者,要监测耳及肝功能情况,静滴不宜过快。

(姜素椿 审)

参考文献

- 侯芳,崔洪,郝凤兰.阿奇霉素与罗红霉素随机对照治疗 30 例对细菌性感染的临床评价.中国临床药理学杂志,1994,10(3):129
- 张之荫.阿奇霉素的药理临床及与其他药物的交互作用.国外医药抗生素分册,1997,18(2):146
- Blanc F, D Enfert J, Fiessing S et al, An evaluation of tolerance of roxithromcin in adults. J Antimicrob Chemother, 1987, 20(SupplB):179
- 王明忠,张婴元.新大环内酯类抗生素-阿奇霉素,新药与临床,1997,16(1):38
- 姜红,马海波.罗红霉素的体内分布与相互作用.中国新药杂志,1997,6(4):257

6 姜素椿 · 大环内酯类抗生素的临床药理 · 国外医药抗生素分册, 1997, 18(2) : 156

7 孙曼琴 · 大环内酯类抗生素的临床药理 · 国外医药抗生素分册, 1997, 18(2) : 156

8 梁晓丽, 东 宁 · 罗红霉素过敏性紫癜 1 例 · 药物流行病学杂志, 1997, 22(1) : 55

9 Wallace MR · 阿奇霉素的耳毒性 · 国外医学药学分册, 1995, 17(2) : 122

10 Benichon · 罗红霉素引起急性肝炎 · 药学进展, 1993, 17(2) : 122

11 姜 红, 马海波 · 罗红霉素的临床应用 · 国外医药抗生素分册, 1996, 17(6) : 420

12 Daviol RL, Pharm D, George F *et al* · Disposition of oral azithromycin in humans · Clin pharmacol Ther, 1997, 61: 641

(编校: 黄翔兵 收稿: 1999-06-10)

中级医师资格考试试题选登(30)

耳鼻咽喉科试题

病历摘要 患者男性, 50 岁。广州市籍。晨间涕血伴左侧颞顶部头痛月余。既往健康。体检: 鼻粘膜充血, 双侧鼻道未见肿物生长, 无脓、血性分泌物。鼻咽镜检: 左侧咽隐窝饱满, 局部粘膜粗糙, 未见坏死变黑组织脱落。左乳突尖前下方可扪及一约 4 cm × 8 cm 淋巴结, 质中等硬度, 活动度差, 触痛不明显。

提问 1 初步诊断应考虑哪些疾病?

- A · 鼻咽增生性病变 B · 鼻咽结核 C · 鼻咽纤维血管瘤 D · 鼻窦恶性肿瘤 E · 鼻咽恶性肿瘤 F · 其他癌瘤的颈部转移

提示 左侧中耳腔积液, 音叉检查骨导 > 气导, 呈传导性聋。

提问 2 应进一步作哪些检查处理?

- A · 即行鼓膜穿刺、抽液, 并于中耳腔内注入少许地塞米松注射液, 以减少渗出 B · 电测听检查 C · 脑干反应测听检查 D · 鼻咽及颅底摄 X 线片检查 E · 鼻咽部活检 F · EB 病毒 EA-IgA 检查 G · EG 病毒 VcA-IgA 检查 H · EB-DNA 检查

提示 神经科检查发现左眼球外展障碍、复视、不能转向外下方, 同时出现左眼上睑下垂, 前额及上脸皮肤感觉障碍。

提问 3 可能有哪些颅神经受损?

- A · 视神经 B · 动眼神经 C · 滑车神经 D · 三叉神经 E · 外展神经 F · 面神经 G · 听神经 H · 迷走神经

提示 经鼻咽部活检, 病理报告为“鼻咽低分化鳞癌”。

提问 4 首选何种治疗方案?

- A · 放射治疗 B · 单纯化学药物治疗 C · 单纯中草药内服、外敷治疗 D · 手术切除治疗 E · 单纯免疫

治疗 F · 先用小剂量化疗药物治疗后再行放射治疗 G · 放射治疗并电灼及免疫等综合治疗

提问 5 确诊为鼻咽癌, 属何种临床类型?

- A · 颅神经型 B · 颈淋巴结广泛转移型 C · 混合型 D · A 型 E · D 型 F · AD 型

提示 出现动眼神经、滑车神经、三叉神经第 1 支及外展神经损伤的症状。

提问 6 肿瘤向颅内破坏的途径属哪一条?

- A · 鼻咽 → 蝶腭孔 → 翼腭窝 → 眶下裂 B · 鼻咽 → 颈内动脉管 → 眶下裂 C · 鼻咽部 → 破裂孔 → 圆孔 D · 鼻咽 → 破裂孔 → 岩裂 E · 鼻咽 → 破裂孔 → 海绵窦区 → 眶上裂 F · 咽 → 颈内动脉管 → 圆孔 G · 鼻咽 → 颅中窝 → 颅前窝 → 视神经孔

提问 7 鼻咽癌好发于哪些部位?

- A · 鼻咽底壁 B · 咽鼓管前区 C · 咽鼓管后区 D · 鼻咽顶壁 E · 咽鼓管区 F · 鼻腔与鼻咽腔交界

提问 8 接受放射治疗后可能出现哪些后遗症?

- A · 颈区皮肤、软组织萎缩 B · 口干 C · 颞颌关节功能障碍 D · 放射性脑脊液漏 E · 放射性龋齿 F · 颌骨发育畸形

提问 9 鼻咽癌有哪些流行病学特征?

- A · 有明显的地区性 B · 无明显的地区性 C · 部分人群有易感现象 D · 有人种间差异 E · 致癌因素相对稳定 F · 致癌因素不稳定 G · 有家族聚集现象 H · EB 病毒感染与鼻咽癌的发生有着平行关系 I · 近年来鼻咽癌的发病率有明显上升趋势 J · 亚硝胺类化合物与鼻咽癌的发生有关

(答案见本期第 567 页)